2026-10-26 就诊准备

类型 计划　日期 2026-10-26　地区 太原　来源 自行整理　状态 待核实　就诊人 原凯莉

这次只准备已经挂上的门诊。不写怎么改药，不写怎么办门诊慢特病或残疾证。那些仍等 资料补全计划 里还空着的参保地、药盒照片和当地医保口径。

挂号详情见 2026-10-26-山医大一院挂号。病情原文见 2026-10-14-病情自述。

去之前

☐ 继续按现在正在吃的剂量服药，直到医生当天另有医嘱。不为了抽血或「看真实病情」自行停泼尼松或溴吡斯的明，也不自行加量。2016 年印刷医嘱里没有「不能随意停药」这句；这句只在自述里。手写第 5–7 条仍未核对。

☐ 拍下三个药盒，看清泼尼松、溴吡斯的明每片毫克，以及钙片的药名。照片放进 `00-收件箱/`。现在的笔记里溴吡斯的明只有「每次 1 片」。

☐ 手机里留好：2016-05-09 出院记录和出院医嘱的照片、病情自述、健康山西挂号页。

☐ 家里如果找出 11 岁的出院记录、抗体报告、胸腺 CT 或肌电图，一并带上。找不到就告诉医生原件丢失，不凭记忆报一个具体数值。

☐ 出发前再打开健康山西看是否停诊。预约时间 10:48 只供参考。到院后先点「在线报到」，再去门诊二层 A 区 A205。

若在 10 月 26 日之前出现和现在明显不同的情况，例如平卧时喘不上气、说话变得很费力、吞咽明显变差，先去急诊，不等这次门诊。自述里的「ADL 8 分、危象风险不高」不能当作可以等待的依据。

当天可以问的事

把自述里的诉求当成问题带去，由医生决定做不做、用不用。

1. 现在的抗体、胸腺和病情活动度要查哪些项目。2016 年的抗体和胸腺 CT 原件已经不在家里。
2. 夜间平卧气不够、大笑后气促、说话偶尔有鼻音，需要做哪些呼吸或说话相关的检查。
3. 长期服用泼尼松，血糖、血脂、骨密度、眼底、电解质要不要查。
4. 免疫抑制剂、靶向药、激素是否减量，只能听当天的方案。就诊前不选定药物，也不以「双达标」作为必须达到的要求。
5. 问清这次医保的参保地，以及这个病在当地能不能办门诊慢特病、要哪些材料。问到的口径记下来再入库。挂号单上的统筹 8 元只说明这次挂号用了医保。

不要做的事

- 不按 2016 年出院时的 60 mg、一日 2 次去改现在的溴吡斯的明。那是当时的印刷医嘱。
- 不把健康山西页面上的陪诊、免费试药、商业保险当成医生建议。
- 不在这次门诊办理残疾证。证件由残联按国家标准评定，不是神经内科门诊开具。祁县的口径见 祁县-残疾证办理。家里还没写明是否已经持证。

- 医生名录里其他城市的医生，这次不用再比较。号已经挂在张炜的神经肌肉病门诊。

看完之后

- [ ] 当天的病历、检查单、处方放进 `00-收件箱/`，再按分类归档。
- [ ] 若医生改了药，以新处方为准另写一条医嘱，不改 当前用药 里的旧自述。
- [ ] 若问到了参保地或慢特病材料，补进 资料待核实 的阶段 1 和阶段 3。